

13 - 05- RUPTURE PRÉMATURÉE DES MEMBRANES - Pr. BASSIR

Aujourd'hui on va voir le cours la rupture prématurée des membranes. La rupture prématurée des membranes signifie la rupture franche de l'amnios et du chorion se produisant avant le début du travail, quel que soit le terme de la grossesse. La période de latence, c'est la période entre la rupture des membranes et le début du travail.

La définition de cette période de latence est très controversée. En fonction des équipes, en fonction des centres, il y a des centres qui définissent cette période de latence c'est une heure, d'autres de douze heures, d'autres de vingt-quatre heures, il y a même des centres qui préconisent quarante-huit heures ou soixante-douze heures. Cette définition inclut les fissurations de la poche des os et exclut les ruptures en cours de travail.

Les risques de la rupture prématurée des membranes, c'est l'infection et la prématurité. La conduite à tenir nécessite un diagnostic exact et une évaluation rigoureuse des risques. Elle dépend de l'âge gestationnel au moment de la rupture, de la survenue ou non du travail et de la survenue ou non d'une complication.

En ce qui concerne l'épidémiologie, la fréquence. La fréquence de la rupture des membranes est très variable, entre 6 à 12 % des grossesses. La fréquence est de l'ordre de 8 % à terme et de 2 à 3 % avant terme.

Cette fréquence augmente avec l'âge gestationnel. Les facteurs de risque. Toutes situations qui entraînent une surdistension utérine, à savoir une grossesse multiple, un hydramnios, une baccinose cervico-isthmique, des modifications de la synthèse et de la structure du collagène au cours des maladies de système, le tabac, l'infection et les germes oncogènes, ou bien le portage sain du streptococci dans les infections urinaires.

Toujours dans les facteurs de risque, il y a les antécédents d'un accouchement prématuré, d'une rupture prématurée des membranes, des métrorragies du premier trimestre de la grossesse, les anomalies d'insertion du placenta, à savoir un placenta bas-attaché, l'âge maternel avancé, le niveau socio-économique et les conditions du travail, et il y a les causes traumatiques, plus ou moins iatrogènes, à savoir une amniosynthese tardive. Pour la physiopathologie, on commence par un petit rappel de la structure des membranes. Ces membranes fœtales sont composées de deux couches, l'amnios et le chorion, entre lesquelles se situe la couche spongieuse.

Elle contient des cellules de différents types, hypodermique, mésenchymateuse, trophoblastique, et une matrice à base de collagène. L'amnios est la membrane la plus interne. Elle est composée de collagène et de glycoprotéines.

Elle est plus résistante à l'étirement que le chorion. Sur le schéma, on arrive à repérer l'amnios, le chorion. La couche spongieuse effectue la transmission entre l'amnios et le chorion.

Elle permet à l'amnios de glisser sur le chorion. Elle absorbe l'essentiel des contraintes physiques supportées par les membranes ovulaires pendant la grossesse. Au cours de la grossesse, il y a un équilibre entre les processus de dégradation et de renouvellement des membranes.

L'intégrité est secondaire à une faible concentration des matrices métalloprotéines, qui dégradent le collagène et une activité importante de leurs inhibiteurs tissulaires. La rupture prématurée des membranes est un phénomène complexe dont les causes sont multifactorielles. L'issue du liquide résulte, dans la grande majorité des cas, de brèches spontanées situées au regard de l'orifice interne du col.

Plus rarement, elle résulte de lésions plus hautes consécutives à des gestes invasifs diagnostiques ou thérapeutiques. La rupture spontanée est secondaire à un émincissement focalisé des membranes. Deux mécanismes ont causé, l'apoptose cellulaire et la dégradation du collagène, ce qui entraîne une augmentation de l'activité métalloprotéineuse.

Arrivons aux étiologies. Il y a des facteurs mécaniques qui entraînent un émincissement des membranes, toute situation de surdistension utérine, grossesse multiple et drameus. Dans ces situations, il entraîne une augmentation de la sécrétion des prostaglandines E2.

Une baillance cervico-ésmique. La baillance cervico-ésmique sous-entend une ouverture du col et donc une exposition aux membranes aux germes présents au niveau de la cavité vaginale. Les facteurs chimiques.

Une modification de la synthèse et de la structure du collagène au cours des maladies de système qui s'associe à un émincissement des membranes. Cela entraîne une augmentation de la dégradation du collagène due principalement à l'activité des enzymes collagénolithiques des protéines. Une concentration de la nicotine dans le mucus cervical.

Le rôle de l'infection. Plusieurs germes sont en cause. Les plus fréquents sont le cardénel A vaginalis, l'uréoplasme, les bactéroïdes fragilistes, les trichomonas, ou bien le portage du streptococci B dans les infections génitales urinaires.

Le mécanisme, c'est la production de ces germes. Il entraîne une production excessive de collagénase et donc la production de cellules inflammatoires qui entraînent la sécrétion de protéases et d'élastases. Le diagnostic positif.

Les signes fonctionnels. Le diagnostic de la rupture prématurée des membranes et surtout en amnestique et clinique. Le plus souvent, il est évident.

C'est un écoulement vaginal de liquide clair, incolore, abondant et continu en dehors de tout travail. L'écoulement exagéré par une contraction ou lors de la mobilisation transabdominale de l'utérus, ce qu'on appelle le signe de tarnier. Parfois, ce liquide contient du vernix ou bien il peut

être sanglant, voire méconial.

La survenue de façon soudaine en dehors de tout travail est le plus souvent sans signe d'alerte. L'examen général. À la recherche d'une infection, mesurer la température, la tension artérielle, le pouls, la présence ou non de sueur.

L'examen obstétrical. Il faut mesurer la hauteur utérine pour avoir une appréciation sur la gestationnelle. Voir s'il y a des contractions utérines ou pas.

Entendre les BCF. Et voir la présentation, au cas où, si on préconise un accouchement. L'examen spéculum.

L'objectif est la présence de liquide amniotique dans le cul de sac vaginal postérieur. L'écoulement de liquide par l'orifice cervical. Voir si le col est fermé ou ouvert.

Il permet d'éliminer une procédance éventuelle du cordon ou d'un membre. Il permet de réaliser des prélèvements nécessaires à viser diagnostique et bactériologique. Le toucher vaginal est actuellement déconseillé si la patiente n'est pas en travail.

On fait au début un premier toucher et puis il faut éviter de toucher tant que la patiente ne contracte pas et tant qu'on n'a pas décidé de déclencher le travail ou pas. Il apporte peu d'éléments supplémentaires par rapport à l'examen spéculum. Il augmente le risque infectieux, permet d'avoir une idée sur la longueur, l'ouverture du col et la position du col et permet d'éliminer une procédance du cordon.

Il reste en revanche indiqué si la patiente a des contractions régulières ou lorsqu'on décide de déclencher le travail. Les examens complémentaires Les tests diagnostiques sont inutiles si la rupture est cliniquement évidente. L'intérêt si on a un doute pour affirmer ou infirmer le diagnostic.

Le test à la nitrazine, c'est l'amnicateur, le plus utilisé aux Etats-Unis. Le prélèvement doit être fait dans le cul-de-sac vaginal postérieur sur la paroi vaginale latérale pour éviter le mucus cervical. Le pH alcalin du liquide amniotique fait virer l'indicateur coloré.

Le pH vaginal normal est de 4,5 à 6 alors que le pH du liquide amniotique est voisin de 7,2. S'il y a un changement de couleur de l'indicateur, on peut déterminer s'il y a du liquide dans le vagin. Le test à la diamine oxydase, c'est une enzyme qui présente en grande quantité dans le liquide amniotique après 20 semaines d'améliorer.

Il repose sur le dosage dans les pertes vaginales de cette enzyme. Le dosage du facteur de croissance de l'insuline à l'aide d'un kit spécial dans les pertes cervicales. Sa concentration dans le liquide amniotique est de 100 à 1000 fois plus élevé que dans le sérum maternel.

La spécificité et la sensibilité de ce marqueur sont excellentes. C'est un dosage radioé isotopique

et c'est le test le plus utilisé en France. Il permet un diagnostic rapide au lit de la patiente.

Le prélèvement est réalisé à l'orifice externe du col ou bien du vagin et les résultats sont obtenus en 5 minutes. Ce test paraît adapté au diagnostic des ruptures du deuxième trimestre. Un quatrième test, c'est la protéine placentale alpha-microglobuline, la mise en évidence de cette protéine dans les pertes vaginales par un test immunochromatographique.

Les concentrations sont élevées dans le liquide amniotique de cette protéine alors qu'ils sont faibles dans le son et les excréments vaginales. Ce test peut être pratiqué au lit de la patiente et il permet d'obtenir les résultats dans 10 minutes. Elle a une sensibilité de 99%.

D'autres tests peuvent être utilisés. Le test de cristallisation en feuilles de faugère, la recherche de squins foetales, le test sulfato-bleu de Nile à la recherche de cellules oranges spécifiques de squins de fœtus, le dosage de l'alpha-futoprotéine. Ces tests sont peu d'intérêt et sont absolument abandonnés.

La myosynthèse avec injection d'indigo carmine sous contrôle échographique. En cas de rupture, le colorant paraît dans les pertes vaginales. On injecte l'indigo de carmine au niveau de la cavité amniotique, parfois sous guidage.

On va voir s'il y a l'issue de ce liquide coloré au niveau des pertes vaginales. L'inconvénient, c'est un geste invasif. Il peut en lui-même entraîner une rupture qui n'existait pas.

La réalisation est difficile en cas d'oligoamniose sévère. Il n'y a pas de liquide, c'est difficile. Les examens biologiques, il faut réaliser un bilan infectieux pour diagnostiquer une chorioamnionite ou une infection infraclinique.

Ce test consiste à demander une C réactive protéine, chercher une hyperleucocytose, à savoir que l'hyperleucocytose chez la femme enceinte, c'est à partir de 15 000. Dosage de la glucosamine, mais ça nécessite une agno-synthèse. Il faut réaliser des prélèvements bactériologiques en but étiologique, un prélèvement vaginal ou bien endocervical et un examen cytot bactériologique des urines.

Pour le bilan fœtal, on réalise une échographie obstétricale, un enregistrement du rythme cardiaque fœtal et le profil biophysique de Manu. On a vu le diagnostic positif, on va passer au diagnostic différentiel. Comme diagnostic différentiel de la rupture prématurée des membranes, il y a la rupture de la poche amniocoréale.

C'est une petite poche qui existe en dehors des membranes et sa rupture donne un tableau clinique similaire à la rupture de la poche des os. La différence, c'est que quand cette poche est vide, on n'aura plus d'écoulement et lorsqu'on réalise une échographie, on trouve le liquide en quantité normale. Les fuites urinaires, l'hydrométrie gravidique, l'évolution, la durée de latence et les variables selon les patients et l'âge gestationnel.

60 % des patients rentrent en travail après 24 heures alors que 77 % rentrent en travail après 72 heures. Les complications et comme complications redoutables, c'est l'infection maternelle et c'est la coriole amniocyte. Les germes responsables sont les mycoplasmes, les anaérobies, le streptocoque et les chirurgiens-coli.

Le diagnostic clinique est posé suite à la surveillance régulière de la température maternelle pendant la phase de latence et pendant le travail. On peut avoir une hyperthermie maternelle supérieure à 38 ou bien 37,8 à deux reprises sans autre cause évidente d'infection et fortement évocatrice. Le diagnostic, la présence de deux des symptômes suivants posent le diagnostic positif de la coriole amniocyte.

La complexibilité vétére, la tachycardie maternelle supérieure à 100, un liquide dosé avant, une tachycardie foetale supérieure à 160 par minute, en cas de fièvre, hémoculture qui met en évidence une bactérie innée avant tout traitement antibiotique, une CRP positive et une hyperglycémie. Donc la présence de deux symptômes posent le diagnostic de la coriole amniocyte. Dans les infections, il y a le risque d'endométrite en postpartum avec risque de péllivipéritonite et de choc septique.

Les complications gravidiques c'est la procédance du cordon, des présentations irrégulières, la procédance des membres, un décollement placentaire ou bien une dystocie dynamique. Et les complications foetales et néonatales, la souffrance foetale aiguë, la prématurité et comme complication la maladie des membranes myélines, l'hypoplasie pulmonaire, le syndrome de détresse respiratoire aiguë due à une infection maternelle foetale et les dysplasies bronchopulmonaires. Également, il y a risque de lésions cérébrales et des troubles de développement neuro-comportemental.

Et si la rupture survient avant 22 semaines, il y a un risque de déformation des membres avec un retard de croissance et une déformation faciale qui est semblable au syndrome de Potter. Et bien sûr, le risque d'infection néonatale. Les moyens thérapeutiques, l'hospitalisation est de règle, elle est systématique et exige un repos strict avec bien sûr des mesures d'asepsie, il faut une toilette intime avec un gel antiseptique à pH neutre 2 fois par jour, mettre des garnitures stériles, interdire les touchés vaginaux, sauf si contraction itérative.

L'antibiothérapie à base de bêta-lactamine elle est systématique si on a un streptocoque B et positif, à terme, le bénéfice est diminué en dehors de portage de streptocoque B. Puis, cette antibiothérapie doit être orientée par la microbiologie. Donc, en ce qui concerne l'antibiothérapie, on l'administre systématiquement à base de bêta-lactamine après la réalisation, bien sûr, des examens bactériologiques. La tocolyse, si la gestationnelle est inférieure à 37 semaines, elle est obligatoire s'il y a des contractions utérines après avoir éliminé une chorioamniotite, est systématique pendant les 48 heures controversées.

Les contre-indications de la tocolyse c'est la chorioamniotite, la mort foetale, l'hématome

rétroplacentaire et l'élément de formation fœtale. Il faut donner des médicaments qui accélèrent la maturité pulmonaire, la corticothérapie, surtout si la rupture prématurée des membranes survient avant 34 semaines d'améliorer. Et bien sûr, cette corticothérapie doit être donnée après avoir éliminé une infection, pour ne pas aggraver l'infection.

Le déclenchement artificiel du travail comme moyen thérapeutique, c'est en fonction du score de Bishop, donc ce déclenchement se fait par les oocytocycles ou bien par les prostaglandies. La conduite obstétricale. Avant 28 semaines, il faut préconiser l'expectative, expliquer aux parents que le pronostic est sévère.

Il faut une surveillance clinique de la température des contractions étheriques du liquide, pour voir s'il y a un virage du liquide amniotique. Un bilan biologique, la NFS, la CRP, toutes les 48 à 72 heures. Et l'échographie obstétrique pour voir la vitalité et quantifier le degré de l'oxygène amniote.

L'antibiothérapie, elle est systématique, elle doit être adaptée en fonction des prélèvements bactériologiques et si mort fœtale ou bien s'il y a des signes de coriandre amniotique, à ce moment-là, il faut faire une IMG avec un déclenchement artificiel du travail. Entre 28 et 35 semaines d'améliorer, donc toujours l'hospitalisation, une surveillance clinique quotidienne, biologique, NFS, CRP, toutes les 48 à 72 heures, faire une échographie une fois par jour, une antibiothérapie adaptée, une corticothérapie, tocolise en dehors des contreindications et attendre jusqu'à 35 semaines d'améliorer puis déclencher artificiellement le travail. Plus de 35 semaines d'améliorer, il faut le repos avec des mesures d'asepsie, éviter les touchées, faire un bilan infectieux, NFS, CRP, faire une échographie, un ERCF, une antibiothérapie, un déclenchement artificiel du travail.

Donc il faut attendre la durée de latence en principe dans notre service, c'est 24 heures ou bien immédiatement, mais pas de touchées vaginales. En fonction du score de Bishop, on peut utiliser soit des oocytocycles, soit des prostaglandins. En cas de chorioamnionite, quels que soient les termes, l'antibiothérapie est systématique, c'est une antibiothérapie par voie intraveineuse, la plus rapidement possible, dès la réalisation des prélèvements bactériologiques.

2 g d'amoxicilline, il faut arrêter la grossesse par la voie la plus rapide. Le plus recommandé, c'est un accouchement par voie basse. Parce qu'il y a, c'est mieux que la césarienne, lorsqu'on fait une césarienne, il y a risque de dissémination de germes dans la cavité abdominopelvienne.

Et si on décide de faire une césarienne, il faut penser à faire des prélèvements des membranes du placenta, avec une protection des gouttières et un lavage abondant de la cavité abdominopelvienne. Bien sûr, ces prélèvements doivent être adressés pour études bactériologiques et anatomopathologiques. La prise en charge néonatale, chez le nouveau-né, en collaboration avec les néonatalogues, faire des prélèvements bactériologiques chez le nouveau-né, une antibiotérapie adaptée en fonction des prélèvements et bien sûr, une

surveillance du nouveau-né.

En conclusion, la rupture prématurée des membranes, c'est une situation qui fréquente en pratique obstétricale courante. La prise en charge fait encore à ce jour l'objet de plusieurs incertitudes. Le risque infectieux maternel et néonatal est augmenté.

Un prélèvement vaginal doit être fait à l'admission et les touchés vaginaux doivent être limités. La conduite à tenir dépend essentiellement de la gestationnelle. Dans la rupture avant-terme, une prise en charge active avec hospitalisation d'emblée et surveillance intensive est nécessaire dès le stade de viabilité fatale.

Il faut, j'insiste, sur le dépistage de l'infection par le streptococope, donc il reste quand même une infection pouvant évoluer à bord. Oui, mais il faut toujours penser à faire un prélèvement vaginal au cours de la dernière consultation à 36 ou 37 semaines pour le dépistage systématique du streptococope B. Je vous remercie.